

Trastorno de Pánico y Agorafobia

1. Introducción y relevancia clínica

El **Trastorno de Pánico (TP)** se caracteriza por la presencia de **crisis súbitas e inesperadas de miedo intenso**, acompañadas de síntomas físicos marcados (palpitaciones, disnea, sensación de muerte inminente) y preocupación persistente por su recurrencia.

A menudo se asocia a **agorafobia**, que consiste en el **miedo a encontrarse en lugares donde escapar o recibir ayuda sería difícil** (como transporte público, multitudes o espacios cerrados), lo que puede llevar al **aislamiento y deterioro funcional severo**.

Su **inicio típico** ocurre entre los **20 y 40 años**, con predominio en mujeres, y su **prevalencia mundial** se estima en torno al **2–3%**.

En Chile, es un diagnóstico **frecuente en urgencias médicas**, donde hasta el 30% de los pacientes con “dolor torácico no cardíaco” tienen un trastorno de pánico no diagnosticado.

□ En el **EUNACOM**, este tema se evalúa constantemente:

- Preguntas diferenciales entre crisis de pánico y causas médicas (IAM, hipoglucemia, asma).
 - Elección del tratamiento adecuado (ISRS + TCC).
 - Manejo agudo vs mantenimiento.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El trastorno de pánico surge de una **alteración en los sistemas neurobiológicos del miedo**, con participación de la **amígdala, locus coeruleus y sistema serotoninérgico**.

2.1. Bases neurobiológicas

- **Hiperactividad del locus coeruleus**, con liberación excesiva de **noradrenalina**, responsable de las manifestaciones autonómicas.
- **Disfunción serotoninérgica (5-HT1A)** en el sistema límbico, que modula la respuesta de ansiedad.

- **Hipocampo y corteza prefrontal medial** muestran menor inhibición del circuito del miedo.
- **Hiperreactividad respiratoria:** sensibilidad aumentada al CO₂ y a la hipercapnia (“teoría del falso ahogo”).

2.2. Factores genéticos y psicológicos

- Riesgo aumentado **4–8 veces** en familiares de primer grado.
- Historia de **trauma infantil, separación o pérdida temprana**.
- Rasgos de personalidad ansiosa o dependiente.

2.3. Concepto de “miedo al miedo”

El paciente desarrolla un **temor anticipatorio** a experimentar nuevas crisis, lo que perpetúa el trastorno y puede conducir a **agorafobia** (evitación fóbica).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Crisis de pánico (ataques de pánico)

Son episodios discretos de **miedo intenso o malestar**, de **inicio súbito y máximo en minutos**, acompañados de **síntomas autonómicos**.

DSM-5:

Se requieren ≥4 de los siguientes 13 síntomas:

Síntomas somáticos	Síntomas cognitivos
Palpitaciones, taquicardia	Miedo a morir
Sudoración	Miedo a perder el control o “volverse loco”
Temblores o sacudidas	Desrealización o despersonalización

Disnea o sensación de ahogo	Sensación de inminente catástrofe
-----------------------------	-----------------------------------

Dolor o molestia torácica	—
---------------------------	---

Náuseas o molestias abdominales	—
---------------------------------	---

Mareo, inestabilidad o desmayo	—
--------------------------------	---

Parestesias	—
-------------	---

Escalofríos o sofocos	—
-----------------------	---

Duración típica: 10–30 minutos (rara vez >1 hora).

Inicio: espontáneo, sin gatillantes claros (distingue del ataque fóbico).

3.2. Trastorno de pánico

Se diagnostica cuando hay:

- Crisis de pánico **recurrentes e inesperadas**, y
 - **Preocupación persistente (≥1 mes)** por tener nuevas crisis, o
 - **Cambio conductual significativo** (evitación de lugares, viajes, situaciones).
-

3.3. Agorafobia

Miedo o ansiedad intensa ante **≥2** de las siguientes situaciones:

1. Usar transporte público.
2. Estar en espacios abiertos (plazas, estacionamientos).

3. Estar en lugares cerrados (tiendas, cines).
4. Hacer fila o estar en una multitud.
5. Estar solo fuera de casa.

El paciente teme **no poder escapar o recibir ayuda** si tiene una crisis.

Esto lleva a **evitación progresiva** y, en casos graves, **reclusión domiciliaria**.

3.4. Curso clínico

- Inicio agudo, con primera crisis en contexto de estrés o consumo de estimulantes.
 - Curso crónico con **oscilaciones**: crisis intermitentes + ansiedad anticipatoria.
 - Alta comorbilidad con **depresión (50%)** y **abuso de alcohol o benzodiacepinas**.
-

3.5. Diagnóstico diferencial

Entidad médica	Características diferenciales
Infarto agudo al miocardio (IAM)	Dolor torácico opresivo, prolongado, asociado a esfuerzo, ECG alterado.
Hipertiroidismo	Taquicardia persistente, pérdida de peso, temblor fino.
Feocromocitoma	Crisis hipertensivas, sudoración paroxística, catecolaminas elevadas.
Hipoglucemia	Sudoración, confusión, síntomas alivian con ingesta de azúcar.
Epilepsia parcial compleja	Aura sensorial, desconexión de conciencia.

- En el **EUNACOM**, se espera reconocer la “crisis de pánico” como **diagnóstico de exclusión** tras descartar causas orgánicas graves.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico**, pero se deben realizar exámenes para **excluir patología orgánica** que simule crisis de pánico.

Examen	Objetivo
ECG	Descartar arritmia o isquemia.
TSH / T4L	Descartar hipertiroidismo.
Glicemia	Descartar hipoglucemia.
Hemograma	Anemia o causas secundarias.
Examen toxicológico	Uso de cocaína, cafeína o anfetaminas.

Criterios DSM-5:

- Crisis recurrentes, inesperadas.
 - ≥1 mes de preocupación o evitación conductual.
 - No atribuible a sustancias ni a otro trastorno mental.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile 2023)

El tratamiento del trastorno de pánico se basa en un **enfoque combinado: farmacológico + psicoterapéutico**.

5.1. Psicoterapia (primera línea)

Terapia cognitivo-conductual (TCC):

- Reestructuración cognitiva de pensamientos catastróficos (“voy a morir”, “me estoy volviendo loco”).
- Exposición interoceptiva: inducir síntomas físicos controlados (p. ej., hiperventilar) para reducir sensibilidad.
- Entrenamiento en relajación y respiración diafragmática.
- Prevención de evitación (exposición gradual a lugares temidos).

□ Evidencia: La TCC logra **remisión completa en 70–80% de los pacientes**.

5.2. Farmacoterapia

Primera línea: ISRS

- **Sertralina:** iniciar 25 mg/día, titular hasta 100–200 mg.
- **Paroxetina:** 10–20 mg/día (útil para ansiedad comórbida).
- **Escitalopram o fluoxetina:** alternativas equivalentes.

□ Los ISRS deben iniciarse **a dosis bajas y aumentar gradualmente** para evitar exacerbación inicial de la ansiedad.

Segunda línea: IRSNa

- **Venlafaxina XR:** 37,5–150 mg/día.

Benzodiacepinas (uso transitorio)

- **Clonazepam 0,25–0,5 mg cada 12 h o lorazepam 1 mg cada 8–12 h**, durante las primeras semanas.
- Suspender gradualmente tras 2–4 semanas, una vez que el ISRS haga efecto.

Otros tratamientos

- **Propranolol:** útil en síntomas autonómicos leves (taquicardia, temblor).
 - **Terapias combinadas:** TCC + ISRS mejora la adherencia y reduce recaídas.
-

5.3. Duración del tratamiento

- Mantener ISRS **mínimo 12 meses** tras remisión completa.
 - Retiro progresivo (reducción 25% cada 2–4 semanas).
 - Continuar psicoterapia como prevención de recaídas.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- **Agorafobia secundaria.**
- **Depresión mayor.**
- **Abuso de benzodiazepinas o alcohol.**
- **Aislamiento social y discapacidad laboral.**

Pronóstico

- **Excelente** con tratamiento adecuado (70–90% mejora significativa).
 - **Mal pronóstico:** inicio precoz, alta evitación, comorbilidad depresiva o dependencia química.
 - Recaídas frecuentes si se suspenden bruscamente los fármacos.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. El **trastorno de pánico** presenta **crisis recurrentes e inesperadas** de miedo intenso + síntomas físicos.
 2. Siempre **descartar causas médicas** antes de diagnosticar.
 3. **ISRS** son el tratamiento de elección, iniciando a dosis bajas.
 4. **TCC** es tan eficaz como los fármacos y esencial para prevenir recaídas.
 5. **Benzodiacepinas solo en fase aguda o transitoria.**
 6. La **agorafobia** surge por **evitación anticipatoria** del malestar.
 7. Educar al paciente sobre la **naturaleza benigna de las crisis** reduce el círculo del miedo.
-



Errores comunes

- Tratar solo con benzodiacepinas por largo plazo.
 - No buscar causa médica (IAM, hipertiroidismo).
 - Iniciar ISRS a dosis altas → aumento inicial de ansiedad.
 - No explicar al paciente que la crisis **no implica daño orgánico**.
 - No indicar TCC o seguimiento psicológico.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **trastorno de pánico** cursa con crisis súbitas e intensas de miedo y síntomas físicos.
2. El diagnóstico es **clínico**, tras excluir patología médica.
3. El tratamiento de elección es **ISRS + Terapia Cognitivo-Conductual**.

4. Las **benzodiacepinas solo se usan brevemente** en la fase inicial.
5. **Agorafobia** es una complicación frecuente por evitación del miedo.
6. Educar y tranquilizar al paciente es parte esencial del tratamiento.
7. El pronóstico es **muy favorable** con tratamiento adecuado y continuidad terapéutica.